



## Öffentliche Anhörung der 16. Sitzung

### **Ausschuss für Gesundheit**

Berlin, den 3. November 2025, 15:15 Uhr  
Reichstagsgebäude, SPD-Fraktionssaal 3 S001

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB

## Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

### **Einzigster Tagesordnungspunkt**

**Seite 6**

Änderungsantrag CDU/CSU, SPD

**Änderungsanträge 16-18 der Fraktionen CDU/CSU  
und SPD zum Gesetzentwurf der Bundesregierung  
für ein Gesetz zur Befugnisweiterung und Entbüro-  
kratisierung in der Pflege (BT-Drs. 21/1511)**

**Ausschussdrucksache 21(14)33**

**Mitglieder des Ausschusses**

| <b>Fraktionen</b>     | <b>Ordentliche Mitglieder</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stellvertretende Mitglieder</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDU/CSU               | Beek, Sascha van<br>Borchardt, Simone<br>Hiller, Dr. Matthias<br>Janssen, Anne<br>Müller, Axel<br>Pauls, Dr. Thomas<br>Pilsinger, Dr. Stephan<br>Schmidt, Sebastian<br>Seitz, Nora<br>Streeck, Dr. Hendrik<br>Theiss, Dr. Hans<br>Weiss, Dr. Maria-Lena<br>Zeulner, Emmi | Albani, Stephan<br>Demuth, Ellen<br>Ehm, Lars<br>Grasse, Adrian<br>Knoerig, Axel<br>Ludwig, Dr. Saskia<br>Müller, Sepp<br>Reddig, Pascal<br>Rupprecht, Albert<br>Staffler, Katrin<br>Stegemann, Albert<br>Timmermann-Fechter, Astrid<br>Walch, Siegfried |
| AfD                   | Baum, Dr. Christina<br>Bloch, Joachim<br>Dietz, Thomas<br>Ebenberger, Tobias<br>Hess, Nicole<br>Schießl, Carina<br>Sichert, Martin<br>Weiss, Claudia<br>Ziegler, Kay-Uwe                                                                                                 | Bessin, Birgit<br>Birghan, Dr. Christoph<br>Bollmann, Gereon<br>Fetsch, Thomas<br>Giersch, Alexis L.<br>Kempf, Martina<br>Möller, Stefan<br>Przygodda, Kerstin<br>Schmidt, Dr. Paul                                                                      |
| SPD                   | Machalet, Dr. Tanja<br>Mieves, Matthias David<br>Moll, Claudia<br>Pantazis, Dr. Christos<br>Schwartz, Stefan<br>Seitzl, Dr. Lina<br>Yüksel, Serdar                                                                                                                       | Ahmetovic, Adis<br>Dittmar, Sabine<br>Glöckner, Angelika<br>Kersten, Dr. Franziska<br>Peick, Jens<br>Schmidt, Dagmar                                                                                                                                     |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Dahmen, Dr. Janosch<br>Fischer, Simone<br>Heitmann, Linda<br>Kappert-Gonther, Dr. Kirsten<br>Wagner, Johannes                                                                                                                                                            | Grau, Dr. Armin<br>Nick, Dr. Ophelia<br>Piechotta, Dr. Paula<br>Rietenberg, Sylvia                                                                                                                                                                       |
| Die Linke             | Gürpinar, Ates<br>Merendino, Stella<br>Schötz, Evelyn<br>Stange, Julia-Christina                                                                                                                                                                                         | Arndt, Dr. Michael<br>Brückner, Maik<br>Fey, Katrin<br>Gebel, Kathrin                                                                                                                                                                                    |



---

## Liste der Auskunftspersonen

Öffentliche Anhörung am 3. November 2025, 15:15 Uhr, Reichstagsgebäude PRT 3 S 001

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (Drucksachen 21/1511, 21/1935)

Ausschussdrucksache 21(14)33

---

- AOK-Bundesverband<sup>1</sup>
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF)<sup>1</sup>
- BKK Dachverband<sup>1</sup>
- Bundesverband Managed Care e.V.<sup>1</sup>
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)<sup>1</sup>
- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)<sup>1</sup>
- Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)<sup>1</sup>
- Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)<sup>1</sup>
- Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)<sup>1</sup>
- IKK Bundesverband<sup>1</sup>
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)<sup>1</sup>
- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See<sup>1</sup>
- Techniker Krankenkasse (TK)<sup>1</sup>
- Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)<sup>1</sup>
- Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Auf Vorschlag aller Fraktionen zur öffentlichen Anhörung eingeladen.



- ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft <sup>1</sup>
- Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) <sup>1</sup>
- Prof. Dr. Christian Karagiannidis<sup>2</sup>  
Universität Witten/Herdecke

---

<sup>2</sup> Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur öffentlichen Anhörung eingeladen.



Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



**Beginn der Sitzung: 15:15 Uhr**

**Einziger Tagesordnungspunkt**

Änderungsantrag CDU/CSU, SPD

**Änderungsanträge 16-18 der Fraktionen CDU/CSU und SPD zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BT-Drs. 21/1511)**

**Ausschussdrucksache 21(14)33**

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD): Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige und sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, allen voran Herr Staatssekretär Dr. Kippels. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie zu unserer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit in etwas ungewohnten Räumlichkeiten. Die Sitzung ist eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns per Zoom zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihren Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns alle erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Online zugeschaltet mit Stimm- und Rederecht sind angemeldet: Herr Dr. Pauls und einige weitere Kolleginnen und Kollegen, die ich hier auf meinem Bildschirm sehe. Meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege auf den Drucksachen 21/1511 und 21/1935. Zum Gesetzentwurf und zu den damals vorliegenden Änderungsanträgen hatten wir bereits am 8. Oktober eine öffentliche Anhörung. Heute befassen wir uns nun mit drei neuen Regelungsvorschlägen der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 21(14)33<sup>3</sup>, die eben eingeführt wurden. Konkret geht es um die Begrenzung des Ausgabenanstiegs bei den Verwaltungskosten der Krankenkassen im Jahr 2026, die Reduktion des Fördervolumens des sogenannten Innovationsfonds im Jahr 2026 und um das Aussetzen der Meistbegünstigungsklausel für das Jahr 2026. Zu diesen Regelungsvorschlägen

wollen wir heute die Meinung der Expertinnen und Experten hören. Bevor wir beginnen, will ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung machen. Es stehen uns heute 60 Minuten zur Verfügung. Die 60 Minuten werden, wie immer, entsprechend der Stärke der Fraktionen in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf zwei Frageblöcke verteilt. Insgesamt entfallen auf die CDU/CSU 20 Minuten, auf die AfD 14 Minuten, auf die SPD 12 Minuten, auf BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 8 Minuten und auf Die Linke 6 Minuten Fragezeit. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, weil nur so viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Die Anhörung wird im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung später auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch darauf hin, dass sie, sobald ihr Redebeitrag beginnt, für uns im Sitzungssaal auf der Wand zu sehen und zu hören sind. Ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Bild nach Ihrem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. im Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Abs. 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Dann noch ein Hinweis an die Gäste auf der hinteren Bank: Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Die erste Frage stellt die Fraktion der CDU/CSU. Sie hat dafür zehn Minuten Zeit. Frau Janssen, bitte.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine erste Frage geht an die Deutsche

<sup>3</sup> Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)33



Krankenhausgesellschaft (DKG) und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband). Welche Folgen erwarten Sie von der beabsichtigten Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel für das Jahr 2026? Könnte diese Maßnahme den befürchteten kalten Strukturwandel in der deutschen Krankenhauslandschaft beschleunigen?

Die **Vorsitzende**: Herr Dr. Gaß, Sie dürfen antworten.

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Die Streichung der Meistbegünstigungsklausel hat die Folge, dass die Krankenhäuser im Jahr 2026 die tatsächlichen Kostensteigerungen, die voraussichtlich im Jahr 2026 anfallen werden, nicht mehr in vollem Umfang refinanziert bekommen, weil durch diese Streichung die sogenannte Obergrenze – dazu sage ich gleich zwei Sätze – von eigentlich 5,17 Prozent auf 2,98 Prozent abgesenkt wird. Diese Obergrenze definiert den Deckel für die Verhandlungen. Es wird immer suggeriert, als ob es hier einen Automatismus gäbe und es insofern zu einer Überfinanzierung der Krankenhäuser über die eigentlichen Kostensteigerungen hinauskommen könnte. Wer das behauptet, hat entweder das System nicht verstanden, oder will bewusst etwas Falsches in der Öffentlichkeit sagen. Jetzt wird der Deckel auf 2,98 Prozent abgesenkt. Das heißt, wenn die Kostensteigerungen über diesen 2,98 Prozent liegen, können die Krankenhäuser in den Verhandlungen darüberhinausgehenden Kostensteigerungen nicht mehr realisieren. Das führt zu einer weiteren Einschränkung im Umfang – so ist auch die Einsparung formuliert – von 1,8 Milliarden Euro. Konkret bedeutet das, dass die 4 Milliarden Euro, die jetzt im Koalitionsvertrag ausgelobt wurden, am 30.11.2026 auslaufen werden. Dann werden die Krankenhäuser schlechter dastehen als heute ohne diesen Rechnungszuschlag, weil ihnen nicht nur der Rechnungszuschlag fehlt, sondern auch der Basiseffekt von 1,8 Milliarden Euro. Das heißt, es fehlen dann knapp sechs Milliarden Euro zu einer kostendeckenden Finanzierung. Das wird definitiv zu einem weiteren Anwachsen des kalten Strukturwandels führen. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Herr Blatt vom GKV-Spitzenverband, bitte.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Vielen Dank für die Frage. Ich möchte mit den Übereinstimmungen mit der DKG beginnen. Auch wir gehen davon aus, dass allein durch diese Regelung etwa 1,8 Milliarden Euro eingespart werden können. Im Gegensatz zur DKG vertreten wir aber die Auffassung, dass, um es noch einmal darzulegen, die technische Folge der Streichung darin liegt, dass die sogenannte Mehrbegünstigungsklausel, so auch der Name, erst einmal dazu führt, dass der extra dafür eingerichtete Orientierungswert, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird, nächstes Jahr mit 2,98 Prozent Steigerung greift. Die Mehrbegünstigungsklausel hätte dazu geführt, dass es aus unserer Sicht eine Überfinanzierung gegeben hätte, nämlich mit der deutlich höheren Veränderungsrate der beitragsfähigen Einnahmen der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Wir sind nicht der Auffassung, dass wir mit dieser aus unserer Sicht wichtigen und sachgerechten Maßnahme, um die Finanzen der GKV zu entlasten, hier von einem kalten Strukturwandel sprechen können. Wir gehen davon aus, dass wir damit zukünftig auch die anfallenden Kosten eins zu eins abdecken können und uns auf die echte Kostensteigerung begrenzen können. Wir kritisieren seit Jahren diese Regelung und begrüßen sie daher ausdrücklich. Abschließend will ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir aber davon ausgehen, dass, wenn nicht zusätzlich auch die Tarifregelung gestrichen wird, sich das Einsparvolumen dadurch etwas mindert, nämlich um 500 Millionen Euro. Das möchte ich schon an der Stelle noch mal sagen.

Die **Vorsitzende**: Frau Janssen, weiter.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Dankeschön. Die nächste Frage geht auch wieder an die DKG und den IKK e.V. Welche Auswirkungen hat die Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel auf die stationäre psychiatrische Versorgung in Deutschland und um welchen Betrag würden sich die Einsparungen verringern, wenn der stationär-psychiatrische Bereich außen vor bliebe?



Die **Vorsitzende**: Herr Dr. Gaß und dann Herr Hohnl für den IKK-Bundesverband.

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Gerald Gaß, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ich will noch nachtragen, ich habe keine besonderen Interessen. Die Auswirkungen auf die Psychiatrie, rein rechnerisch können diese maximal 180 Millionen Euro betragen, bzw. wenn die Psychiatrie ausgenommen werden würde, so war Ihre Frage ja zu verstehen, dann könnte es maximal zu 180 Millionen Euro nicht realisierten Einsparungen oder Kürzungen, ich will es so formulieren, für die GKV kommen, weil die Psychiatrie etwa zehn Prozent ausmacht. Ich will an der Stelle aber auch noch die besondere Situation der Psychiatrie in diesem Zusammenhang betonen. Es ist, ich sage es nochmal, falsch, was eben behauptet wurde, dass der Orientierungswert die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Jahr 2026 abbildet. Der Orientierungswert wird aus vergangenheitsbezogenen Daten zusammengestellt. Es ist ein Wert des Statistischen Bundesamtes, aufgrund der Daten aus dem zweiten Halbjahr 2024 und dem ersten Halbjahr 2025. Der kann niemals die Kostensteigerung im Jahr 2026 abbilden. Für die Psychiatrie bedeutet dies, dass die Beschränkung auf 2,98 Prozent, das ist diese Deckelung, es ihr unmöglich macht, das Bestandspersonal, was ja im Rahmen dieser PPP-Richtlinie [Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses] über Jahre hinweg nachfinanziert werden muss, weil es nie finanziert werden konnte, über diese 2,98 Prozent geltend zu machen. Das wird nicht möglich sein. Das bedeutet, dass die Sanktionen, die am 01.01.2026 greifen, die scharfgestellt werden im Zusammenhang mit der PPP-Richtlinie, in der Psychiatrie mit Sicherheit dazu führen werden, dass etliche Träger bestimmte Versorgungsangebote nicht mehr anbieten, ihr Personal in anderen Bereichen konzentrieren wird, weil sie ansonsten harte Sanktionen befürchten müssten. Noch ein letzter Satz: Wenn man das für die Psychiatrie macht, hat man in einem weiteren Punkt noch einen Fehler gemacht, denn der Orientierungswert 2,98 Prozent, der hier zugrunde gelegt wird, auch in der Psychiatrie, ist der Orientierungswert, wo die Pflege der Somatik herausgerechnet wird. Pflege in Psychiatrie wird anders finanziert. Hier muss der andere Orientierungswert, der mit 3,16 Prozent berechnet ist vom Statistischen

Bundesamt, mindestens angewendet werden, wenn man eine parallele Regelung zur Somatik treffen möchte.

Die **Vorsitzende**: Herr Hohnl.

**Jürgen Hohnl** (IKK-Bundesverband): Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Frage. Jürgen Hohnl, gemeinsam in Vertretung der Innungskrankenkassen, keine Interessenskonflikte. Ich schließe mich dem GKV-Spitzenverband an, dass die Meistbegünstigungsklausel gestrichen wird, ist ein überrückfälliger Vorgang. Die Finanzierung der stationären Strukturen haben sich in den Jahren verändert. Das ist ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, der gehört gestrichen. Auch wir sind der Auffassung, dass mit dem Orientierungswert die tatsächlichen Preissteigerungen abgebildet werden, natürlich mit Zeitverzug, aber sie werden abgebildet. Was die Frage der Versorgung angeht, sind wir der Auffassung, dass auch für die psychiatrische Versorgung keine anderen Regelungen gelten sollten. Der Betrag, der von Herrn Dr. Gaß eben genannt worden ist, ist bei mir etwas höher aufgeschrieben, aber das mag die Quelle sein. Wir hätten 250 Millionen Euro, die dadurch gespart werden, dass die Meistbegünstigungsklausel auch im Bereich der psychiatrischen Versorgung angesetzt wird. Wenn aber nicht die zweite Maßnahme, die auch Herr Blatt eben schon genannt hat, kommt, nämlich die automatische Übernahme der Tarifsteigerungen einsetzt, dann würden 120 Millionen Euro weniger realisiert werden. Das heißt: Wir bleiben dabei - die Versorgung ist nicht gefährdet. Die Preissteigerungen werden abgebildet durch den Orientierungswert und das gilt für den somatischen Bereich wie für den psychiatrischen Bereich.

Die **Vorsitzende**: Wer fragt weiter? Herr Müller, Sie dürfen.

Abg. **Axel Müller** (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, und zwar an Sie, Herr Dr. Gaß. Demokratie lebt bekanntlich vom Kompromiss und die Frage ist deshalb: Wie würden die Krankenhäuser dastehen, wenn wir den Veränderungswert des Jahres 2025, der, glaube ich, bei 4,41 Prozent lag, wieder anwenden würden, um auf





diese Art und Weise ein solches Finanzloch, wie es jetzt zu drohen scheint, zu vermeiden und gleichzeitig vielleicht auch die Beitragsstabilität ein Stück weit garantieren könnten?

Die **Vorsitzende**: Herr Dr. Gaß, Sie dürfen.

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Es wäre in der Tat ein Kompromissangebot. Ich will an der Stelle auch betonen, wir haben es sehr bedauert, dass mit uns in keiner Weise das Gespräch gesucht wurde über mögliche Kompromissangebote. Wir haben immer betont, wir müssen von den Kosten runter, und das korrespondiert mit den Gedanken, die Sie haben. Wenn man uns die Möglichkeit gibt, beispielsweise durch das Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen, die von 95 Prozent der Häuser überhaupt nicht gerissen werden, durch das Aussetzen der Sanktionszahlungen in der Psychiatrie, durch Überregulierung im Krankenhaustransparenzgesetz und durch zu erwartende neue Personalbemessungssysteme, die auch noch kommen - wenn Politik hier handelt, dann könnten wir mit einem solchen Kompromissangebot leben, weil wir dann in der Lage wären, auch unsere Kosten zu senken. Denn wir sind sozusagen Gefangene von vielen kleinteiligen Regelungen. Wir beschäftigen heute 20 Prozent mehr Ärzte pro Fall als im Jahr 2019. Das tun wir nicht, weil wir nicht wissen, wohin mit unserem Geld, sondern das tun wir, weil wir an vielen, vielen Stellen dazu gezwungen werden. Das ist nur ein Beispiel.

Die **Vorsitzende**: Ich gebe weiter an die AfD mit sieben Minuten, Herr Bloch, bitte.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Danke. Was ist der Zweck des Innovationsfonds? Warum wird seine Fördersumme für 2026 auf 100 Millionen Euro reduziert, während sie ab 2027 wieder auf 200 Millionen Euro ansteigt?

Die **Vorsitzende**: An wen geht Ihre Frage bitte?

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): An den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).

Die **Vorsitzende**: Der G-BA ist nicht anwesend.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Dann an den GKV-Spitzenverband.

Die **Vorsitzende**: Dann Herr Blatt, bitte.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Vielen Dank für die Frage. Im Innovationsfonds werden Projekte ausgebaut, die für Innovation in der Versorgung sorgen sollen. Insofern ist das der Sinn und der Zweck. Wir stellen aber fest, insofern halten wir die jetzige Regelung zur Einschränkung für vertretbar, dass wir in den letzten Jahren in dem Fonds alles Geld nicht ausgeben konnten, sodass wir derzeit über 200 Millionen Rücklagen verfügen und daher der Meinung sind, dass man jetzt für das höhere Ziel zur Stabilisierung der Finanzen in der GKV es als vertretbar ansehen, dass wir diese jetzt vorübergehend auf 100 Millionen begrenzen, statt wie üblich auf 200 Millionen.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Dankeschön.

Die **Vorsitzende**: Ja, bitte, Herr Bloch.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Mit welchen durchschnittlichen Zusatzbeitragssätzen rechnet der GKV-Spitzenverband im Jahr 2026 und warum?

Die **Vorsitzende**: Herr Blatt, noch einmal.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Wir gehen davon aus, wenn nichts weiter passiert mit dem vorliegenden Sparpaket, dass die Zusatzbeiträge im kommenden Jahr die 3-Prozent-Marke überschreiten werden im Durchschnitt. Das ist für uns gesichert. Das liegt hauptsächlich daran, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre Finanzreserven noch im Durchschnitt sehr stark auffüllen müssen. Das wird



im Schätzerkreis nicht berücksichtigt. Das ist ein Grund. Wir gehen auch davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr eine starke Ausgangsdynamik haben werden, die zuletzt dazu geführt hat, dass der Schätzerkreis für dieses Jahr die 2,5 geschätzt hat und wir bei 2,9 gelandet sind. Kurzgefasst: Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr durchschnittliche Zusatzbeiträge von über drei Prozent zu erwarten haben.

Die **Vorsitzende**: Herr Bloch, weiter.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Wo sehen Sie konkret Einsparungspotenzial?

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Bei beiden genannten sehen wir Einsparpotenziale. Wir sind der Meinung, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, die GKV zu finanzieren, alle Bereiche im Gesundheitswesen mittragen sollten. Die Krankenhäuser und die Krankenkassen tragen ihren Beitrag dazu bei. Für uns ist daher nicht ersichtlich, weshalb nicht sowohl die Pharmaindustrie einen Beitrag leisten soll als auch die niedergelassene Ärzteschaft. Bei der Pharmaindustrie sehen wir einiges an Vorschlägen, die wir in der Stellungnahme abgegeben haben. Ich will explizit die Absenkung des Herstellerabschlages nennen, die wir als Leuchtturm sehen. Bei der niedergelassenen Ärzteschaft sind wir der Meinung, dass die mit dem Terminversorgungsgesetz eingeführten Vergütungen für die Terminvermittlungen gestrichen sind. Sie haben sich als nicht wirksam erwiesen und durch einen technischen Fehler im Nachhinein haben wir eine Doppelabrechnung von etwa 400 Millionen Euro, die sich heute wiederfindet. Da würden wir es begrüßen, wenn wir den Mut hätten, das auch noch in die Sparpakete mit aufzunehmen.

Die **Vorsitzende**: Herr Bloch.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Wie ergibt sich der Veränderungswert für 2026? Wieso verlässt man sich beim Orientierungswert auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, welches gerade in der jüngsten Vergangenheit durch manipulierte Zahlen aufgefallen ist?

Die **Vorsitzende**: Die Frage geht an den GKV-Spitzenverband?

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Ja.

Die **Vorsitzende**: Bitte, Herr Blatt.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Mir ist nicht bekannt, dass das Statistische Bundesamt zu manipulierten Zahlen neigt. Dafür kenne ich keine Beispiele. Insofern ist das für unsere Arbeit eine Behörde, auf die wir uns verlassen. Deshalb sehe ich da auch keinen Punkt, warum wir darüber nachdenken sollten, uns nicht an diesem Orientierungswert zu orientieren.

Die **Vorsitzende**: Bitte, weiter.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): An die IKK. Wie leistet diese Maßnahme einen Beitrag zur nachhaltigen Begrenzung des Ausgabenanstiegs in der GKV? Welche Alternativen zur Finanzierung des Fonds wurden diskutiert?

Die **Vorsitzende**: Herr Hohnl, bitte.

**Jürgen Hohnl** (IKK-Bundesverband): Herzlichen Dank für die Frage. Wie ich eben schon gesagt habe, die Meistbegünstigungsklausel ist ein überkommendes Instrument und würde zur Einsparung führen. Die Zahlen sind genannt. 1,8 Milliarden sind genannt. Es werden weniger werden, wenn nicht die Anpassung mit der Refinanzierung der Tarife einhergeht. Ansonsten zur Finanzierung haben wir mehrere Vorschläge gemacht. Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass der Staat die Einnahmen von Tabak und Alkoholsteuer in eine Abgabe zugunsten des Gesundheitsfonds umwandelt. Damit würden die Finanzen der GKV deutlich entlastet. Es würde einen effektiven Beitrag zur Verstärkung der Prävention in diesen beiden Bereichen leisten. Herzlichen Dank.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): An die BDA bitte. Kritisch betrachtet: Ist diese Halbierung



verhältnismäßig oder könnte sie langfristig die Innovationskraft der GKV schwächen, insbesondere bei medizinischen Leitlinien für spezielle Bedarfe?

Die **Vorsitzende**: Frau Wagemann von der BDA, bitte.

**Susanne Wagemann** (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)): Mir ist unklar, worauf sich die Halbierung bezieht. Ich gehe davon aus, auf den Innovationsfonds. Ich sehe hier tatsächlich keine Gefahr für die Innovationskraft. Die Innovationskraft kommt in der Regel unter anderem aus der Forschung, die nicht zwingend über den Innovationsfonds gefördert wird. Wir haben vorhin vom GKV-Spitzenverband gehört, dass die Mittel des Innovationsfonds auch nicht immer vollständig ausgeschöpft werden. Insoweit sehe ich hier keine Gefahr. Die Innovationskraft in der Wirtschaft, die nicht hier gefördert wird, sehe ich als deutlich größer an.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Dr. Pantazis. Nein, Frau Moll, bitte schön.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Wir beraten heute Änderungsanträge, mit denen wir die GKV entlasten, mit dem Ziel, den durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz im nächsten Jahr bei 2,9 Prozent zu belassen. Die Mitglieder haben bereits erhebliche Beitragssatzerhöhungen im Jahr 2025 getragen. Auch zum 1. Januar 2026 erwarten wir weitere Beitragssatzerhöhungen bei einzelnen Kassen. Bitte erläutern Sie uns vor diesem Hintergrund, wie aus Ihrer Sicht ein ausgewogenes Maßnahmenpaket aussehen sollte, um die mittel- und langfristige Stabilität der GKV-Financen zu gewährleisten, aber ohne die Personaluntergrenze auszusetzen.

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD): Herr Blatt, Sie haben fünf Minuten für das Gesamtpaket.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Für das Gesamtpaket. Wir haben zum Ausdruck gebracht, dass das kleine Paket für das, was Sie beschrieben haben,

nicht ausreichen wird, weil das Finanzvolumen zu klein ist. Unser ausgewogenes Paket sieht aus, dass wir der Meinung sind, das habe ich eben auch schonmal erläutert, dass wir noch weitere Einsparmaßnahmen in anderen Bereichen benötigen. Wir sind der Meinung, dass alle im Gesundheitswesen relevanten Bereiche ihren Beitrag leisten müssen bei einem solchen Sparpaket. Wir Krankenkassen, die Krankenhäuser, die Arzneimittelhersteller und auch die niedergelassene Ärzteschaft. Wenn man da mutig herangeht, könnten wir uns vorstellen, dass wir zumindest für das kommende Jahr eine Finanzstabilität gewährleisten könnten. Das können wir derzeit nicht. Darüber hinaus brauchen wir auch noch Strukturreformen. Die Krankenhausreform ist auf dem Weg. Allerdings befürchten wir weiterhin zu viele Verwässerungen dieser Krankenhausreform, dass sie am Ende nicht die Wirkung entfaltet. Wir brauchen auch im niedergelassenen Bereich strukturelle Reformen über das kommende Jahr hinaus, die wir angehen sollten. Notfallreform ist noch ein Stichwort. Das als Paket wäre für uns ein erster Schritt, um für 2026 Arbeitgeber und Versicherte von weiter steigenden Zusatzbeiträgen zu verschonen, die sich sonst aus unserer Sicht unwiderruflich andeuten werden.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Geht an die Techniker Krankenkasse (TK) und an die Bundesknappschaft. Der vorliegende Änderungsantrag begrenzt den Anstieg der sächlichen Verwaltungskosten der Krankenkassen, und zwar der absoluten Beiträge. Uns liegen aus dem Kassenlager sowohl Vorschläge vor, an diesem Verfahren festzuhalten, als auch einen Versicherungsbezug herzustellen. Bitte erläutern und begründen Sie uns Ihren Vorschlag.

Die **Vorsitzende**: Wir haben Herrn Baas online zugeschaltet für die TK und dann Frau Brakel für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See.

**Dr. Jens Baas** (Techniker Krankenkasse (TK)): Jens Baas, Techniker Krankenkasse. Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Die ist in der Tat sehr wichtig. Zunächst muss ich sagen: Wir begrüßen das komplette Paket, das gerade verabschiedet werden soll, in allen drei Bereichen. Auch ausdrücklich, dass auch bei den Krankenkassen



gespart werden soll. Auch die sächlichen Verwaltungskosten sind ein Punkt, an dem man gut sparen kann. Wir haben allerdings ein Problem. Die sächlichen Verwaltungskosten hängen zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Menge der Versicherten ab. Da sind Dinge drin wie Post- und Fernmeldegebühren – eindeutig abhängig davon, wie viele Versicherte man hat. Da ist Versand von Kundeninformationen, Kundenmagazinen mit drin, abhängig von den Versichertenanzahlen. Da sind Abrechnungsdienstleistungskosten mit drin. Da sind Verbandsbeiträge drin. Die Verbände berechnen sich nach den Versicherten, nach den Mitgliedern. Dann müssen unsere Mitarbeiter mit Arbeitsplätzen ausgestattet werden, müssen IT-Lizenzen bekommen. Das heißt, in Summe sind etwa 50 Prozent aller Kosten ganz unmittelbare Sachkosten, die an den Personalkosten hängen. 30 Prozent hängen mittelbar daran. Um Ihnen eine Größenordnung für das Problem zu geben: Wir haben etwas über 90 Krankenkassen. 70 Krankenkassen haben weniger Versicherte, als die TK allein dieses Jahr aufgenommen hat. Das heißt, wir müssen die irgendwie nebenher verkraften. Dieses Wachstum lässt sich nicht abbilden, wenn die sächlichen Verwaltungskosten nicht auf die Versicherten bezogen werden. Deswegen ist es für uns super-wichtig, dass diese acht Prozent bleiben, aber dass man sie auf die Versicherten bezieht und nicht auf die Absolutsumme. Zusätzlich haben Krankenkassen, wie meine, extrem niedrige Verwaltungskosten. Wir haben jetzt ein Gesetz, was, wenn ich es überspitzt sage, bedeutet: Wenn du schon sehr hohe Kosten hast und kein Versicherter zu dir kommt, dann kannst du deine Kosten weiter ausbreiten. Wenn du geringe Kosten hast, die Versicherten kommen zu dir, darfst du nicht steigern. Wir glauben, das ist ein handwerklicher Fehler und würden deswegen dafür plädieren, eine Korrektur zu machen, die einfach bedeutet: Verwaltungskosten je Versicherten dürfen nicht steigen. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Frau Brakel, bitte.

**Petra Brakel** (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See): Vielen Dank für die Frage. Keine Interessenskonflikte. Meine Stellungnahme ergeht auch im Namen der Barmer, der DAK, der Kaufmännischen Krankenkasse, der Siemens-BKK, der Bahn-BKK und der IKK. Wir setzen uns dafür ein,

dass die Regelung so bleibt, wie sie ist. Das heißt, dass sie auf einen absoluten Veränderungswert abzielt und nicht pro Versicherten gerechnet wird. Aus den folgenden Gründen: Bei Sachkosten handelt es sich im Großen und Ganzen um Fixkosten, das heißt Aufwendungen für Immobilien, der gesamte IT-Bereich, Lizenzen, Abschreibungen. Fixkosten sind, wie der Name schon sagt, nur langfristig, das heißt nicht kurz- und mittelbar abbaubar und sie sind in großen Teilen durch gesetzliche und vertragliche Zusagen gebunden. Das heißt, in der Umsetzung benötigen Krankenkassen Sachkosten, insbesondere für die Betreuung der Versicherten. Das heißt, insbesondere die Krankenkassen, die einen hohen Anteil an versorgungsbedürftigen Versicherten haben, das sind auch die Krankenkassen, die Versicherte verlieren, haben höhere Fixkostenbedarfe. Sachkosten sind eben gerade kein Gradmesser für die Effizienz einer Krankenkasse.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann wäre jetzt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Reihe. Frau Heitmann, bitte.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich würde meine erste Frage gerne an Herrn Baas von der TK richten und Sie einmal sehr allgemein fragen, ob Sie die von der Koalition heute vorgelegten Änderungsanträge denn als geeignet erachten, um das notwendige Einsparvolumen tatsächlich zu erreichen, das notwendig wäre, um die Kassenbeiträge zu stabilisieren. Oder welche weiteren Maßnahmen hätten Sie sich noch gewünscht, die tatsächlich sehr kurzfristig auch umsetzbar wären?

**Dr. Jens Baas** (Techniker Krankenkasse (TK)): Vielen Dank für die Frage. Ich könnte sie sehr knapp beantworten und sagen: Nein, ich halte sie nicht für geeignet und vor allem nicht für ausreichend. Sie sind im Prinzip gut. Ich hatte das gerade erläutert. Sie werden aber nicht ausreichen. Wir haben vom GKV-Spitzenverband gehört, der durchschnittliche Beitragssatz wird über drei Punkte steigen. Diese Einschätzung teilen wir. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen. Die liegen auf der Hand. Wir haben schon in mehreren Legislaturperioden zum Beispiel eine Erhöhung des



Herstellerabschlags gehabt. Der würde auf einen Schlag drei Milliarden Euro bringen. Das heißt, mehr, als wir alles gerade gehört haben, mehr als bei den Krankenhäusern etc. zu holen wäre, ohne dass wir dort Auswirkungen auf die Versorgung hätten. Das heißt, eine sehr einfache Maßnahme, die dazu führen könnte, dass wir im nächsten Jahr den Beitragssatz stabilisieren können. Natürlich haben wir nach wie vor das Thema der Nichtfinanzierung der Bürgergeldempfänger. Das bringt uns zehn Milliarden Euro. Das heißt, hier hätten wir sogar ein bis zwei Jahre Puffer, um dort wirkliche Maßnahmen umzusetzen. Auch das Thema Arzneimittelfokuslisten, Themen wie Begrenzung von Budgetsteigerungen im ambulanten Bereich sind alles Themen, die uns noch zusätzliche Beiträge liefern könnten. Von daher, klare Aussage: Es geht in die richtige Richtung. Es ist zu wenig. Wir müssen mehr tun, mit dem wir im nächsten Jahr wirklich Beitragssatzanstiege verhindern können.

Die **Vorsitzende**: Frau Heitmann, bitte.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich gern Herrn Moormann von der Verbraucherzentrale noch fragen, wo denn eigentlich aus der Verbraucher- und in dem Fall Patientenperspektive Ineffizienzen in der Versorgung momentan insgesamt gesehen wird? Wo müssten strukturelle Reformen aus Ihrer Sicht angesetzt werden, um tatsächlich für Verbraucherinnen und Verbraucher beziehungsweise Patientinnen und Patienten konkret was zu verbessern?

Die **Vorsitzende**: Herr Moormann ist auch online zugeschaltet. Sie haben noch knapp zwei Minuten für die umfängliche Frage.

**Thomas Moormann** (Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)): Vielen Dank, Frau Dr. Machalet. Vielen Dank, Frau Heitmann, für die Frage. Tatsächlich gehen die Finanzierungsprobleme in der GKV auf eine hochproblematische Ausgabenentwicklung zurück und diese zum großen Teil auf Ineffizienzen in der Versorgung. Falsch wäre es daher, primär nach zusätzlichen Finanzierungsquellen zu suchen, denn auch die zusätzlichen Einnahmen würden wie vom Schwamm aufgesaugt

werden, ohne dass die Menschen dadurch gesünder werden würden. Aus Verbrauchersicht wiegen zwei Aspekte besonders schwer. Das sind zum einen die Überkapazitäten im stationären Bereich und der Zustand, dass Krankenhäuser Behandlung und Eingriffe vornehmen dürfen, denen es an Qualifikation, Ausstattung und Routine fehlt und das Krankenhäuser an unnötigen und zu frühen Eingriffen verdienen. Das macht das System unfassbar teuer und ist ein Hauptgrund für die nur mittelmäßigen Ergebnisse. Versorgungsqualität und Patientensicherheit lassen sich nur bei konsequenter Spezialisierung und Abbau von Krankenhausstandorten und Betten erzielen. Das ist Verbraucherschutz. Erschwerend kommt hinzu, dass es den Patienten sehr schwer gemacht wird, sich bei der Wahl eines Krankenhauses an der Ergebnisqualität der Häuser auszurichten. Der zweite Aspekt ist die schlechte Versorgung alter und chronisch kranker Menschen. Patienten müssen zu lange auf bedarfsnotwendige Termine warten und die Sprechzeiten selbst sind viel zu kurz. Hier setzen die Vergütungsmechanismen massive Fehlanreize. Belohnt wird die Leistungsmenge, nicht der Outcome, nicht die Gesundheit.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Damit hätten wir jetzt noch drei Minuten für die Linken. Frau Stange, bitte.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gaß. Aus dem Sondervermögen wurden den Krankenhäusern vier Milliarden Euro zugeteilt. Nun sollen Sie nach den Berechnungen der Bundesregierung 1,8 Milliarden dafür wieder herausgeben. Welchen Eindruck macht die krankenhauspolitische Strategie der Bundesregierung auf Sie?

Die **Vorsitzende**: Herr Dr. Gaß, bitte.

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Die vier Milliarden Euro sind Ergebnis der Koalitionsverhandlungen und sind dem Grunde nach schon so im Koalitionsvertrag angelegt gewesen. Im Haushaltsbegleitgesetz ist nachzulesen, dass dies eine Finanzierung ist für die nicht realisierten Kostensteigerungen aus den Jahren



2022 und 2023. Das heißt, man hat vonseiten der Koalition die von uns über Jahre hinweg und auch von den Ländern reklamierte Lücke in der Krankenhausfinanzierung erkannt und wollte sie, zwar mit Einmalzahlungen, aber immerhin, für einen gewissen Zeitraum ausgleichen. Das zeigt im Übrigen die Insuffizienz der Krankenhausfinanzierung, der regelhaften Erhöhung der Landesbasisfallwerte bei entsprechend sprunghaften Inflationsentwicklungen. Was jetzt passiert ist, dass diese vier Milliarden Euro, die ja nicht basiswirksam eingepreist sind in die Landesbasisfallwerte, sondern für einen begrenzten Rechnungsaufschlag genutzt werden im Umfang von 3,25 Prozent und die am 30. November des nächsten Jahres auslaufen, dann wieder komplett auf null zurückgeführt werden. Gleichzeitig hat man jetzt parallel dazu schon wieder 1,8 Milliarden Euro dieser vier Milliarden weggenommen, indem man hier durch den Eingriff, der heute hier in Rede steht, die Landesbasisfallwerte nicht entsprechend steigert. Das heißt im Ergebnis - ich komme aus Rheinland-Pfalz, Blick nach Luxemburg, Echternacher Springprozession - zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, was die Regierung hier macht. Darüber hinaus wird sie sogar dafür sorgen, hat sie eben deutlich gemacht, dass am 1. Dezember 2026 die Krankenhausfinanzierung und die Lücke zwischen Kosten und Erlösen größer ist als heute ohne die Rechnungszuschläge und ohne diesen Eingriff. Die Kostenlücke wird dann eben vier Milliarden plus 1,8 Milliarden betragen, nämlich 5,8 Milliarden Euro. Das ist ein eklatanter Wortbruch. Es ist eine Situation, die den Krankenhäusern keine Planungssicherheit mehr gibt in der Wirtschaftsplanung. Sie führt auch dazu, dass die Banken kein Vertrauen mehr darin haben, dass eine mittelfristige Wirtschaftsplanung für die Krankenhäuser möglich ist und in eine Refinanzierung von möglichen Krediten.

Die **Vorsitzende**: Danke. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde. Zehn Minuten für die CDU/CSU-Fraktion. Herr Dr. Theiss, bitte.

Abg. **Prof. Dr. Hans Theiss** (CDU/CSU): Ich hätte eine erste Frage an Herrn Blatt und dann an Herrn Baas. Wie viel Geld müssten wir denn noch drauflegen, damit sicher keine Krankenkasse einen Zusatzbeitrag von über drei Prozent nächstes Jahr erhebt?

Die **Vorsitzende**: Herr Blatt. Konkrete Frage.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Das sind ja immer die schwierigsten Fragen. Vielen Dank. Wir gehen davon aus, dass, damit die Krankenkassen ihre Finanzreserven auffüllen können, wir etwa 0,1 Prozent Beitragsatzpunkte benötigen nächstes Jahr allein dafür. Das heißt, das müssten wir auffüllen. Ich tue mich etwas schwer, das einen Milliardenbetrag hier in den Raum zu stellen, weil es sehr schwierig ist, dies einzuschätzen, wie individuell die Krankenkassen ihre Reserven auffüllen müssen. Für uns ist nur klar, dass das Paket im Moment dafür deutlich zu klein ist.

Die **Vorsitzende**: Herr Baas.

**Dr. Jens Baas** (Techniker Krankenkasse (TK)): Um das zu ergänzen, dass keine Krankenkasse erhöhen muss, kann man, glaube ich, nicht sagen, weil es Krankenkassen gibt, die extreme Ausreißer nach oben haben im Beitragssatz. Aber damit im Schnitt der Beitragssatz gleichbleibt, bräuchten wir 0,1 bis 0,2 Beitragssatzpunkte mehr. Ein Beitragssatzzehntel sind zwei Milliarden. Also wir reden von zwei bis vier Milliarden Euro mehr, die wir bräuchten.

Abg. **Prof. Dr. Hans Theiss** (CDU/CSU): Vielen Dank für die Klarstellung.

Die **Vorsitzende**: Ja. Bitte, Herr Theiss.

Abg. **Prof. Dr. Hans Theiss** (CDU/CSU): Ich hätte noch eine zweite Frage. Die geht auch an Herrn Blatt und an Herrn Baas. Was ist Ihrer Meinung nach das Einsparpotenzial, wenn wir die Zahl der Krankenkassen von über 90 auf 20 bis 25 durch Fusionen reduzieren würden?

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Aus meiner Sicht haben Sie da kein Einsparpotenzial. Verwaltungskosten der Krankenkassen sind Kosten, die entstehen zur Betreuung der Versicherten digital und vor Ort. Wir haben weiterhin, egal wie viele Krankenkassen, 90 Prozent der Bevölkerung, die gesetzlich



versichert ist. Wir möchten auch weiterhin diesen Service bieten. Aus meiner Sicht ist das eine Diskussion, die völlig am Thema vorbeiführt. Der Markt wird das auch regeln, wie viele Krankenkassen wir zukünftig haben. Ich bin ein großer Fan des Wettbewerbs, der auch bei den Verwaltungskosten bisher gezeigt hat, dass er gezogen hat. Die Verwaltungskosten der Krankenkassen sind im Vergleich zu vor fünf bis sechs Jahren deutlich schon gesunken, auf mittlerweile nur noch 4,1 Prozent und das trotz der großen Herausforderungen im Bereich Digitalisierung. Aus meiner Sicht gibt es hier kein großes Einsparpotenzial.

Die **Vorsitzende**: Herr Baas.

**Dr. Jens Baas** (Techniker Krankenkasse (TK)): Ich war Unternehmensberater. Deswegen kann ich nicht sagen, gar keines. Da ist ein gewisses Potenzial drin, aber wirklich minimal. Wir müssen überlegen, welche Funktionen man dort einsparen könnte. Wir haben das vorhin auch schon gesagt. Viel ist einfach abhängig von der Anzahl der Versicherten. Zwei Krankenkassen haben dann nachher genauso viele Versicherte zusammen, wie sie vorher gehabt haben. Das heißt, man kann nicht sehr viel einsparen, sondern nur Overhead-Funktionen, also zum Beispiel HR-Funktionen in der Krankenkasse. Man kann im Vorstand einsparen. Da reden wir vielleicht in Größenordnungen von fünf Prozent. Das macht in Millionen wenig aus. Wenn wir uns anschauen, was in der echten Welt passiert, z. B. in Österreich, die haben sowas gemacht und dann sind die Kosten sogar deutlich gestiegen. Man darf nie unterschätzen, dass so eine Fusion wirklich Kosten erzeugen kann und nicht nur spart. Aber selbst rein theoretische fünf Prozent sind wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von daher stimme ich Herrn Blatt zu.

Die **Vorsitzende**: Herr Müller, bitte.

Abg. **Axel Müller** (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage an den AOK-Bundesverband und an den Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber. Es geht mir um die Annahme, die dieser Beitragsstabilität zugrunde gelegt wird. Es wird davon ausgegangen, dass wir ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent erzielen. So

jedenfalls die Prognose aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Wie sieht die Sache aus, wenn wir - gegenwärtig haben wir das ja - null Wachstum haben? Oder wenn wir nur 0,9 oder 1,0 Prozent Wachstum haben? Können Sie dann sagen, dass die Beitragsstabilität bei diesem Einsparvorschlag, der hier zugrunde liegt, bei diesem Änderungsantrag, dann gewährleistet ist? Oder wie viel fehlt dann in der Kasse?

Die **Vorsitzende**: Da haben wir zunächst Herrn Hoyer vom AOK-Bundesverband und dann Frau Wagemann für den BDA, bitte.

**Jens Martin Hoyer** (AOK-Bundesverband): Jens Hoyer, AOK-Bundesverband. Auch keine Interessenkonflikte. Ich gehe zunächst davon aus, dass der Schätzerkreis nach bestem Wissen und Gewissen die Einnahmen- und Ausgabensituation geschätzt und ermittelt hat. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, sodass man sich hier auf langjährige Erfahrungen berufen kann. Falls diese Einnahmesituation nicht eintreten sollte, ist die Logik des Fonds so, dass das zunächst zulasten der Liquiditätsreserve läuft. Zulasten der Einnahmen des Fonds, sodass die Beitragssatzsituation im Folgejahr zunächst nicht betroffen ist. In den darauffolgenden Jahren hat man das entsprechende Nachholpotenzial. Darauf würde ich auch den Fokus legen. Die eigentlichen Herausforderungen, die wir haben, ist nicht die Beitragssatzstabilität im Jahre 2026, sondern die eigentliche Herausforderung liegt auf der Jahressgrenze 2026/2027, wo Kreditfinanzierung ausläuft etc. pp, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, lieber heute als morgen, wie man mit den entsprechenden Situationen umgehen möchte.

Die **Vorsitzende**: Frau Wagemann.

**Susanne Wagemann** (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)): Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Hoyer anschließen. Ich möchte noch auf eines hinweisen. Das geht nochmal in die gleiche Richtung. Wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Die Ausgaben steigen jedes Jahr deutlich stärker als die Einnahmen. Insoweit brauchen wir tatsächlich Strukturreformen, die wir lieber heute als



morgen angehen, weil sie Zeit brauchen werden, bis sie tatsächlich wirken, die dann auch den Ausgabenanstieg begrenzen.

Die **Vorsitzende**: Sie haben noch vier Minuten. Herr Dr. Theiss, bitte.

Abg. **Prof. Dr. Hans Theiss** (CDU/CSU): Ich hätte eine Frage an Herrn Karagiannidis und dann noch einmal an Herrn Blatt. Wenn alle mithelfen sollen, müssen wir auch die Patienten ins Boot holen. Als Arzt bin ich der Meinung, das kann man ihnen auch zumuten, sozial gestaffelt. Was ist Ihrer Meinung nach, Herr Karagiannidis, geeignet, um Patienten zu beteiligen? Selbstbehalt zum Beispiel, auch Erhöhung der Zuzahlung zu Arzneimitteln? Dann würde ich auch gerne die Einschätzung vom GKV-Spitzenverband hören.

Die **Vorsitzende**: Herr Karagiannidis ist online zugeschaltet. Bitte.

**Prof. Dr. Christian Karagiannidis** (Universität Witten/Herdecke): Vielen Dank. Christian Karagiannidis, Universität Witten-Herdecke. Die meisten Gesundheitssysteme auf der Welt haben irgendeine Form der Selbstbeteiligung bei den Ausgaben im Gesundheitswesen. Ich zitiere immer wieder gerne das niederländische Modell. Da sind Konsultationen der Hausärzte ausgenommen von der Selbstbeteiligung, aber fachärztliche und alles, was darüber hinausgeht. Die Niederländer legen das einmal im Jahr fest. Im Moment ist der Tarif ungefähr bei 385 Euro, die jeder Versicherte oder jede Versicherte zuerst leisten muss. Aus allen Analysen wissen wir, dass es dazu führt, dass die Überinanspruchnahme, die, zweifelsohne im deutschen Gesundheitswesen besteht, damit zurückgeht und ein gewisses Incentive gesetzt wird, dass auch wieder mehr Eigenverantwortung kommt. Deswegen klar, ja, eine gewisse Selbstbeteiligung werden wir brauchen. Ich glaube, man sollte das Geld, das man zusätzlich einnimmt, dann dafür verwenden, Zeit zu gewinnen, um die notwendigen Strukturreformen durchzuführen oder es das erste Mal auch wirklich in Prävention investieren. Wenn wir daran denken, was gerade in den 30er-Jahren auf uns zukommt mit der Welle der Alten, ist es, glaube ich, dringend notwendig, dass wir deutlich mehr in Prävention

investieren.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann Herr Blatt für die GKV-Spitzenverband.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): In einem solidarischen Krankensystem sind solche Diskussionen natürlich nicht leicht, weil sie auch immer eine soziale Komponente haben. Die Vergangenheit hat gezeigt, wir hatten ja schon das Thema beim Arztbesuch einen Betrag zu erheben, dass a) es kaum Steuerungswirkungen gab und b) finanziell auch vernachlässigbar war. Ich muss, ehrlich gesagt, Sie als Ökonom eigentlich fragen, aber ich darf ja keine Fragen stellen, warum nicht die Arzneimittelhersteller zuerst in die Verpflichtung genommen werden, die in unserem Land sehr viele Gewinne machen? Warum wird gleich die Frage nach der Eigenbeteiligung der Patienten gestellt? Das kann man in einem gewissen Rahmen tun, das will ich als Ökonom gar nicht in Abrede stellen. Aber sie in den Fokus stellen, um Milliardenbeträge zur Stabilisierung der Krankenkassen in den Raum zu stellen, würde ich als Spitzenverband erst mal nicht zustimmen und im Moment auch nicht für adäquat halten, weil ich die Gefahr der sozialen Probleme, die wird uns dann einholen... Das müssen Sie genau abwägen. Ab wann halten sie nämlich kranke Menschen dann davon ab, ein Medikament nicht mehr in Anspruch zu nehmen, würde ich da hintenanstellen und bin deshalb kein großer Fan von solchen Diskussionen, im Moment jedenfalls. Da haben wir bessere Optionen.

Die **Vorsitzende**: Dankeschön. Eine schnelle Minute. Herr Müller.

Abg. **Axel Müller** (CDU/CSU): An Herrn Dr. Gaß, und zwar in der Frage Personaluntergrenzen. Da ist jetzt die Diskussion entstanden, wie viel Handlungsspielraum brauchen Sie denn, damit das funktioniert, ohne dass die Personaluntergrenzen völlig abgeschafft werden?

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Ich kann in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir heute 30 Prozent mehr





Pflege pro Patienten haben als im Jahr 2019. Das heißt also, das Pflegebudget hat gewirkt. Die Pflegepersonaluntergrenzen haben gewirkt. Wir haben den Personalbestand in der Pflege deutlich erhöht. 95 Prozent der Krankenhäuser sind unauffällig bei den Pflegepersonaluntergrenzen. Trotzdem werden 100 Prozent der Häuser jeden Tag im Dreischichtbetrieb kontrolliert und dokumentiert. Unser Vorschlag ist, dass wir, anknüpfend an die ja vorhandene Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus sagen: Wer hier mindestens 80 Prozent des Sollniveaus erfüllt - und hier geht es ja nicht um Pflegepersonaluntergrenzen - der sollte in einem ersten Schritt freigestellt werden. Das heißt, nicht abschaffen, sondern aussetzen für die Häuser, die ausreichend Pflegepersonal haben. Danke.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Damit wäre die AfD jetzt noch einmal an der Reihe mit sieben Minuten. Herr Bloch, bitte.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Dankeschön. An die DKG: Mit welchen Konsequenzen beim Leistungsangebot der Krankenhäuser rechnen Sie bei Abschaffung der Meistbegünstigungsklausel?

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Vielen Dank. Ich hatte in einer der vorhergehenden Antworten darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen müssen, wenn alles so kommt, wie es jetzt im Gesetzentwurf steht, dann ab 1.12.2026 in Summe knapp sechs Milliarden Euro fehlen in der Krankenhausfinanzierung. Das sind die vier Milliarden, die auslaufen zu diesem Zeitpunkt, und es sind die 1,8 Milliarden, die ja basiswirksam dauerhaft bleiben. Das heißt, die kommen im Jahr 2027 nicht wieder ins System, wenn nicht etwas geändert wird. Diese knapp sechs Milliarden Euro werden dazu führen, und dazu gibt es Untersuchungen des Deutschen Krankenhausinstituts, dass die Krankenhäuser einfach gezwungen sind, um Insolvenzen zu vermeiden - und das ist natürlich das Ziel der Krankenhausträger, Insolvenzen zu vermeiden und insgesamt Versorgung noch sicherstellen zu können -, dass die besonders defizitären Bereiche konsolidiert werden müssen. Das klingt erst einmal rein technisch, aber es bedeutet, dass dort, wo Geburtshilfe sich nicht mehr lohnt, diese Geburtshilfe abgebaut wird. Dass Pädiatrie,

die nach wie vor schwierig ist in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, zurückgeführt wird. Dass Versorgung in ländlichen Räumen, die darunter leidet, dass unser heutiges Finanzierungssystem diese Versorgungsbereiche nicht auskömmlich finanziert, zurückgeführt werden muss. Die Antwort auf die Frage ist: Wir werden deutliche Konsolidierungsanstrengungen erleben mit Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten. Die erfolgen nicht nach einer Krankenhausplanung eines Landes, sondern durch den Markteffekt des kalten Strukturwandels, und der kennt keine Bedarfsprognosen, was die Patientenversorgung angeht.

Die **Vorsitzende**: Bitte, Herr Bloch.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Ich würde gerne die gleiche Frage jetzt an die AOK stellen. Danke.

Die **Vorsitzende**: Herr Hoyer, bitte.

**Jens Martin Hoyer** (AOK-Bundesverband): Zunächst möchte ich mich nochmal den Ausführungen des Kollegen Blatt im Zusammenhang mit der Meistbegünstigungsklausel anschließen. Es wurde ausführlich ausgeführt, dass die Meistbegünstigungsklausel aus unserer Sicht - quasi anders als von der DKG dargestellt - Überfinanzierung und eben keine Orientierung an der entsprechenden Logik, die hier zugrunde gelegt werden sollte, darstellt. Insofern ist eigentlich zu erwarten, dass die Krankenhäuser - so wie es auch in der Vergangenheit oft Tradition und auch lange gelebt wurde im deutschen Gesundheitswesen - auch mit einem Orientierungswert handlungsfähig sind, der sich dann entsprechend an der Preissteuerungs-Obergrenze orientiert.

Die **Vorsitzende**: Herr Bloch, bitte.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): An die Bundesregierung: Wie verteilt sich die reduzierte Förderung? Warum werden speziell die Budgets für kurzlaufende Projekte...

Die **Vorsitzende**: Kleiner Hinweis: In der öffentlichen Anhörung sind die Expertinnen und Experten



diejenigen, die antworten. An die Bundesregierung werden regulär in den öffentlichen Anhörungen keine Fragen gestellt.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Danke, das wusste ich nicht. Nochmal an den GKV-Spitzenverband. Wie ergibt sich der Veränderungswert für 2026 und wieso verlässt man sich beim Orientierungswert auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes?

Die **Vorsitzende**: Herr Blatt, bitte.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Die Frage hatte ich eben schon beantwortet. Die haben Sie mir gerade eben schon gestellt. Ich kann weiter nur sagen, warum sollten wir uns nicht darauf verlassen, wenn es dafür ein Bundesamt in diesem Land gibt. Wir haben keine Hinweise, dass das nicht verlässlich ist.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD): Danke. Nochmal an die DKG: Welche Auswirkungen hat diese Begrenzung auf die Budgets von Krankenhäusern, insbesondere in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen? Wie wird sichergestellt, dass die Kostensteigerungen durch Inflation abgedeckt sind?

Die **Vorsitzende**: Herr Dr. Gaß, bitte.

**Dr. Gerald Gaß** (Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)): Vielen Dank. Ich will an dieser Stelle noch einmal erläutern, warum die immer wiederholte Botschaft der Vertreter der GKV, es ginge darum, eine mögliche Überfinanzierung zu verhindern, mit dieser Maßnahme falsch ist. Um es noch einmal zu sagen: Der Veränderungswert, der Orientierungswert, das, was wir jetzt festlegen wollen, die 2,98 oder 5,17 Prozent, sind ein Deckel. Unterhalb dieses Deckels dürfen die Krankenhäuser mit den Krankenkassen darüber verhandeln, in welchem Umfang die Landesbasisfallwerte im kommenden Jahr steigen sollen. Werden sich diese Verhandlungspartner nicht einig in diesen Verhandlungen, gibt es einen Schiedsstellenautomatismus, der anhand der vorgelegten Zahlen, Daten und Fakten eine Erhöhung festsetzt. Das heißt also, es gibt

keinen Automatismus. Es kann auch eigentlich keine Überfinanzierung geben, weil es nicht um die Preissteigerung der Vergangenheit geht, sondern es geht um die Preissteigerung, die in der Zukunft zu erwarten ist. Insofern muss man sich, glaube ich, oder diejenigen, die bisher hier gesprochen haben, sich nochmal die Technik vor Augen führen. Es ist ein Deckel. Unterhalb dieses Deckels darf verhandelt werden. Und jetzt konkret zu Ihrer Frage: Wenn dieser Deckel zu niedrig gesetzt ist, dann kann eben nicht mehr von unserer Seite eine zu erwartende Preissteigerung oberhalb der 2,98 Prozent verhandelt werden. Das heißt, solche Forderungen von uns, auch wenn sie belegt werden können durch Tarifentwicklungen und ähnliches, gehen ins Leere. Das bedeutet, dass dann natürlich die Krankenhäuser, auch die psychiatrischen Krankenhäuser, schauen müssen, wie sie Kosten und Erlöse in Einklang bringen. Denn das sind ja Wirtschaftsunternehmen und keine Behörden, wo man sagt, na ja, ist dann vielleicht nicht so schlimm, irgendjemand bezahlt es. Es muss also ein Ausgleich hergestellt werden. Der kann im Zweifelsfall nur hergestellt werden, indem Kosten reduziert werden. Diese Kostenreduktion wird auch im psychiatrischen Bereich dann eben notwendigerweise nicht in allen Standorten, aber doch in einigen Standorten dazu führen, dass bestimmte Versorgungsangebote, die sich wirtschaftlich definitiv nicht berechnen, eingeschränkt werden müssen, um den Standort insgesamt am Netz zu halten. Denn das ist schon unser Ziel selbstverständlich. Wir wollen Patientenversorgung sichern, aber wir können es natürlich nicht um den Preis machen, dass die Standorte betriebswirtschaftlich untergehen.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann wäre jetzt die SPD an der Reihe mit sechs Minuten. Herr Dr. Pantazis.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage würde sich an den GKV-Spitzenverband richten. Herr Blatt, wir hatten ja schon in unserer Anhörung am 8. Oktober, da hatten Sie bereits zu einer notwendigen MGV-Bereinigung [Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung] extrabudgetärer fachärztlicher Behandlungsfälle in Folge des Terminservice- und versorgungsgesetz ausgeführt. Halten Sie an Ihren Aussagen fest und rufen Sie uns bitte kurz in Erinnerung, um welche



Summe es sich hier gehandelt hat und geht.

Die **Vorsitzende**: Herr Blatt, bitte.

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Vielen Dank für die Frage. Wir halten an dieser Aussage weiterhin fest. Wir reden nach unserer Meinung um mindestens 400 Millionen Euro, die wir bei einer Bereinigung einsparen könnten. Ich möchte noch mal dazu auch ausführen, dass es nicht nur darum geht, dass es eine Doppelfinanzierung ist, sondern dass wir auch im Ergebnis gesehen haben, dass wir hier dieses Geld ausgeben, ohne dass es für die Versorgung besser wird. Das sollte uns bei all unseren Diskussionen auch ein wenig leiten. Wofür geben wir denn in diesen Zeiten Geld aus, und wird dadurch die Versorgung verbessert? Das Ziel wurde nicht erreicht, bessere Terminvergabe, weniger Wartezeiten. Zudem gab es noch die Doppelfinanzierung. Wir gehen von etwa 400 Millionen Euro aus. Insofern halten wir an unserer Aussage weiterhin fest.

Die **Vorsitzende**: Herr Pantazis, bitte.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD): Ich hätte noch eine zweite Frage an den GKV-Spitzenverband. Können Sie bitte hier kurz darstellen, was es bedeutet, die sogenannte Meistbegünstigungsklausel für ein Jahr auszusetzen und ob Krankenhäuser dadurch in Existenznot geraten, zumal die Tarifsteigerungen über den Orientierungswert finanziert werden?

**Oliver Blatt** (Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)): Vielen Dank für die Frage. Ich versuche es noch einmal darzulegen, dass aus unserer Sicht dem nicht so ist. Unsere Sicht der Dinge ist, dass wir durch Aussetzen der Mehrbegünstigungsklausel, die ja schon im Namen trägt, dass es in der Vergangenheit für eine unserer Sicht nicht nachvollziehbare Mehrbegünstigung gab, wo man sich immer einem höheren Wert bedient hatte. Ja, wir verhandeln unterhalb dieses Wertes. Da lege ich auch großen Wert darauf, dass wir auch selbst beim niedrigen Deckel natürlich verhandeln, bedarfsgerecht im Einzelfall. Aber wir halten es also absolut für sachgerecht. Wir gehen

davon aus, von 1,8 Milliarden Euro, die wir dadurch einsparen. Wenn wir aber nicht gleichzeitig die Regelungen zur Tarifentwicklung anpassen, dann wird sich dort eben eine gegenläufige Tendenz entwickeln mit etwa 500 Millionen Euro, so dass wir am Ende dann nur noch von etwa 1,3 Milliarden Euro reden. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, Herr Pantazis. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Ja, bitte, Sie dürfen weiterfragen.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD): Herzlichen Dank, keine weiteren Fragen.

Die **Vorsitzende**: Dankeschön. Dann sind jetzt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Reihe. Herr Dr. Dahmen.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will vielleicht eingangs zunächst sagen, dass wir heute hier zu dieser Anhörung zusammengekommen sind, liegt daran, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bundesgesundheitsministerin im Umfeld der Tagung des Schätzerkreises gerne ihr Versprechen einlösen wollte, dass es im nächsten Jahr keine Beitragssteigerung gibt und dann mit sehr heißer Nadel Änderungen beschlossen wurden, um die noch zum Verfahren des Schätzerkreises zu machen und deshalb diese Änderungsanträge jetzt hier vorgelegt hat. Jetzt hören wir aus verschiedenen Statements heute, dass Zusatzbeiträge über drei Prozent im kommenden Jahr unvermeidbar sind, weil die Maßnahmen nicht ausreichen, letztlich zwei bis vier Milliarden fehlen. Ich frage mich: Sind die vorgelegten Maßnahmen hier abschließend oder gibt es nicht noch andere Dinge, die man tun kann? Ich würde deshalb gerne Herrn Karagiannidis als Einzelsachverständigen fragen wollen: Sie haben sich ja jetzt in unterschiedlichen Rollen sehr umfangreich mit der Gesundheitspolitik beschäftigt. Ist das alles? Gibt es nichts, was man sonst tun kann, um weitere Gelder einzusparen?

Die **Vorsitzende**: Bitte, Herr Dr. Karagiannidis.



**Prof. Dr. Christian Karagiannidis** (Universität Witten/Herdecke): Christian Karagiannidis, Universität Witten/Herdecke. Wir haben vor ungefähr einem Jahr zusammengesessen und die Notfallreform diskutiert. Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass wir pro Jahr ungefähr fünf Milliarden Euro sparen würden, wenn wir die wirksam umsetzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ist hergegangen und hat aus ihrem eigenen Budget heraus Teleärzte an die 116 117 gesetzt [Terminservice-Telefonnummer], die in der Lage sind, 80 Prozent der Fälle fallabschließend zu behandeln. Das Ganze läuft seit Juni. Wir lassen ein unglaublich großes Potenzial seit einem Jahr liegen, weil wir keine Notfallreform haben, die wir wirklich ganz, ganz dringend durch den Bundestag bringen müssten. Das entspricht 0,25 Beitragspunkten, diese fünf Milliarden, die wir haben. Wir sollten die unbedingt und ganz schnell angehen. Das, was Herr Baas eben gesagt hat, dass man natürlich ad hoc den Rabatt bei den Arzneimittelpreisen verändern kann, würde zusätzlich nochmal eine Entlastung bringen. Ich glaube, der dritte Punkt, den man erwähnen muss: Wir müssen auch ein Stück weit langfristig denken, da wir in Deutschland ja nun wirklich wenig für Prävention tun, ist es, glaube ich, dringend notwendig, dass wir darüber nachdenken - und das wäre eine Maßnahme, die man auch ad hoc tun könnte -, dass wir die Steuern auf hochprozentigen Alkohol erhöhen, dass wir die Tabaksteuern stark erhöhen und dass wir auch die Zuckersteuern deutlich erhöhen. Wir haben sehr gute Daten weltweit, dass das einen sofortigen Effekt hat. Beispiel Zuckersteuern bei Kindern: Der Body-Mass-Index geht sofort runter. Das sind Daten aus Amerika. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen über diese drei hinaus, mit denen wir das Ganze stabilisieren könnten, aber vordringlich erscheint mir die Notfall- und Rettungsdienstreform.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank für die Antwort. Ich würde gerne noch nachfragen wollen. Jetzt kam im Rahmen der Anhörung vorhin der Vorschlag, man könnte ja die Personaluntergrenzverordnung für die Pflege aussetzen, wenn 80 Prozent eingehalten werden. Das klingt für mich so ein bisschen „Wenn man ein Jahr 80 Prozent der Fälle bei Grün gefahren hat, dann kann man im nächsten Jahr auch bei Rot fahren, wird dann nicht mehr kontrolliert und

sanktioniert.“. Ist das angesichts der Debatte um Strukturvoraussetzungen, dass sich Menschen darauf verlassen können, dass dort, wo Krankenhaus draufsteht, auch das Personal drin ist. Ist das sachgerecht, dieser Vorschlag?

Die **Vorsitzende**: Bitte, Sie können antworten.

**Prof. Dr. Christian Karagiannidis** (Universität Witten/Herdecke): Wenn ich zurückblicke, was in den letzten zehn Jahren passiert ist und was wir gerade in den 2010-er-Jahren erlebt haben, mit den Pflegefachpersonen, dass sie immer weniger geworden sind in den Krankenhäusern, muss man rückblickend schon sagen, dass die Pflegepersonaluntergrenzverordnung eine der wenigen Maßnahmen war, die das System. und das sage ich jetzt mal so aus klinischer Sicht, ein Stück weit stabilisiert hat. Man kann sicherlich darüber sprechen, wie man sie ausgestaltet und ob es an der einen oder anderen Stelle reformbedürftig ist. Da kann man sicherlich drüber sprechen. Aber es war eine der wenigen Maßnahmen, die dazu geführt hat, dass diese starke Fluktuation, die wir in der Pflege gesehen haben, im Krankenhaus ein Stück weit zum Stillstand gekommen ist. Das widerspiegeln die Pflegefachpersonen im Klinikalltag auch immer. Gerade bei uns in der Intensivmedizin mit diesem strengen Schlüssel von eins zu zwei, ist das etwas, was wirklich viel gebracht hat. Ich würde daran nicht rütteln. Sonst haben wir wieder das gleiche Phänomen wie in den 2010er-Jahren.

Die **Vorsitzende**: Dankeschön. Dann abschließend noch Die Linke mit drei Minuten.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Bleidorn: Das deutsche Gesundheitssystem wird immer häufiger als ineffizient und veraltet kritisiert. Welche Funktionen sehen Sie hier beim Innovationsfonds und welches Signal geht nach Ihrer Ansicht von den geplanten Kürzungen aus?

Die **Vorsitzende**: Danke. Frau Bleidorn ist für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin hier.



**Jutta Bleidorn** (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)): Ja, genau. Vielen Dank für die Richtigstellung, Frau Vorsitzende. Ich bin auch Lehrstuhlinhaberin Lehrstuhl Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Jena. In dem Zusammenhang habe ich einen Interessenkonflikt, als dass ich natürlich auch wissenschaftliches Personal beschäftige, das über Projekte des Innovationsfonds finanziert wird. Der Innovationsfonds ist unserer Meinung nach ein relevantes Förderinstrument mit erheblichem Potenzial. Denn im Rahmen des Innovationsfonds werden Projekte gefördert, die nicht nur auf Patientenebene, sondern auch auf Systemebene Maßnahmen systematisch strukturiert mit Kosten-Nutzen-Analyse untersuchen können. Dafür haben wir kaum andere Fördermechanismen. Herkömmliche Forschung über das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und über die Deutsche Forschungsgemeinschaft adressiert Grundlagen, adressiert patientenbezogene Forschung, aber systembezogene Forschung bzw. Evaluation von Maßnahmen auf Systemebene kommt zu kurz. Als Beispiel: Im Innovationsfonds werden viele Projekte gefördert, die Prozesse untersuchen, die neue Prozesse evaluieren, entwickeln, die Delegation beispielsweise untersuchen und letztendlich dazu beitragen, dass wir Maßnahmen mit High-Value-Care, also mit hohem Wert für die Versorgung, identifizieren und umsetzen. Wir kennen alle die Grenzen und Probleme des Innovationsfonds. Ich denke, die Kürzung setzt ein ungutes Signal, zumindest in der Höhe. Wenn, dann sollte auf jeden Fall ein halbes, wirklich auf ein Jahr begrenzt werden und überlegt werden, inwieweit der Innovationsfonds gezielter ausgerichtet werden kann.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Geben Sie mir die Chance für eine zweite Frage an Herrn Moormann. Vorhin wurde von der Überbeanspruchung des Gesundheitssystems durch Patienten gesprochen. Können Sie das aus Patientensicht einordnen?

Die **Vorsitzende**: Herr Moorman, bitte.

**Thomas Moormann** (Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)): Vielen Dank für die Frage. Das mache ich sehr gerne. Das ist für mich aus unserer

Sicht eine nicht zutreffende Analyse. Denn die meisten Versicherten gehen im Jahr drei bis fünf Mal in eine Arztpraxis - ältere und kranke, chronisch kranke Versicherte deutlich häufiger. Die haben den Schnitt auf den Gesamtdurchschnitt zehn Besuche pro Jahr. Hier muss man ansetzen. Eine höhere Zuzahlung, wenn die gefordert wird, würde Menschen mit geringerem Einkommen und aus einer fernerer Bildungsgeschichte von der Inanspruchnahme abhalten. Die Gesundheitschancen würden noch schlechter verteilt, als sie schon ungleicher verteilt sind. Richtig ist aber, dass eine gut gemachte Ersteinschätzung Orientierung geben würde. Wer würde diese nicht gerne in Anspruch nehmen?

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Damit wären wir am Ende unserer öffentlichen Anhörung für heute. Ich darf mich bei allen bedanken, vor allem bei den Sachverständigen, dass sie uns ihre Expertise haben zuteilwerden lassen. Für heute schließe ich die Sitzung. Wir sehen uns im Gesundheitsausschuss wieder am Mittwoch zu neuer Uhrzeit, 11 Uhr.

Schluss der Sitzung: 16:20 Uhr

gez.

Dr. Tanja Machalet, MdB  
**Vorsitzende**